

위암 진단 첫 30일

내시경 절제 · 수술 · 항암 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 03

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

조기위암은 내시경으로, 진행위암은 수술과 항암으로 — 병기가 길을 나눕니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Gastric Cancer, Version 4.2026 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 조기위암과 진행위암

30초 요약

- **조기위암**은 암이 위 점막·점막하층까지만 있는 경우로, 조건이 맞으면 **내시경 절제(ESD)**로 치료할 수 있습니다.
- **진행위암**은 근육층 이상으로 들어간 경우로, **수술이 중심**이며 병기에 따라 항암을 더합니다.
- 한국은 위암 진료 경험이 세계적으로 많은 나라입니다. 국내 진료 지침과 국제 지침(NCCN)이 일부 다르며, **둘 다 근거가 있는 전략**입니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
선종(저도·고도이형성)	전암병변. 내시경 절제가 흔함	담당의 확인(절제 후 암으로 나올 수 있음)
선암(분화형: 고·중분화)	가장 흔한 위암	이 책 전체
미분화형, 반지세포암	내시경 절제 기준이 더 엄격	4·6장
신경내분비종양, GIST, 림프종	위에 생기지만 다른 병	별도 상담

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사·조직형 확인	Day 0-3
②	복부 CT·내시경 초음파 등 병기 검사	Day 3-14

순서	할 일	시기
③	헬리코박터 검사 결과 확인	첫 진료
④	내시경 절제 vs 수술 vs 항암 먼저 결정	Day 7-21
⑤	치료·식사 준비	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 조기위암인가요, 진행위암인가요?
2. 내시경 절제가 가능한가요, 수술이 필요한가요?
3. 치료를 정하기 전에 어떤 검사가 더 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 바로 연락하거나 응급실로

- **피를 토하거나 검은 변(짜장 같은 변), 어지럼·실신**
- 심한 복통이 점점 심해지고 배가 딱딱해짐
- 음식·물을 계속 토함, 방귀·배변이 멈추고 배가 부풀어 오름(장폐색 가능성)
- **시술·수술 후:** 38°C 이상 발열 + 심해지는 복통, 상처 발적·고름, 흑변·토혈
- 식후 1~3시간 뒤 식은땀·떨림·어지럼(후기 덤핑 저혈당) → 바로 사탕·주스. 의식이 흐려지거나 삼키지 못하면 119, 반복되면 진료 때 상의
- 항암 중 38°C 이상 발열(해열제보다 먼저 연락), 하루 4~6회 이상 설사, 손발이 붉게 붓고 벗겨짐
- 면역치료 중·후(몇 달 뒤에도) 심한 설사·혈변, 숨참, 심한 피로·어지럼, 눈·피부 노래짐
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 토혈·흑변은 종양이나 시술 부위 출혈일 수 있습니다.
2. 점점 심해지는 복통과 딱딱한 배는 천공 가능성이 있습니다.
3. 반복 구토·배변 정지는 위출구나 장이 막힌 신호일 수 있습니다.
4. 수술 후 발열·복통은 연결 부위 누출이나 감염 가능성이 있습니다.
5. 후기 덤핑 저혈당은 식사 방법 조절로 줄일 수 있습니다.
6. 항암 중 발열·심한 설사·손발 피부 변화는 연락 기준입니다. 먹는 항암제를 빠뜨렸을 때 두 배로 먹지 말고 문의하세요.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과 받기 ② 위암 진료팀(소화기내과·위장관외과) 예약 ③ 복용 약(특히 혈액을 묽게 하는 약) 정리.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지 — 선종인지 암인지, 분화도
- ☐ 위암 진료팀 예약(내시경 절제와 수술이 모두 가능한 병원이면 편리)
- ☐ 혈액을 묽게 하는 약(아스피린·항응고제 등) 복용 여부 기록 — 내시경 시술 전 중단 여부를 의료진이 정합니다

이번 주 할 일

- ☐ 복부·골반 CT, 필요 시 내시경 초음파·PET/CT 일정
- ☐ 헬리코박터 검사 결과와 제균 계획 확인
- ☐ 가족력(위암, 대장암 등) 정리 — 젊은 나이에 진단됐거나 가족력이 강하면 유전상담 문의
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내, 병원 원무과 대행이 많음)
- ☐ 식사량·체중 기록 시작

오늘 물어볼 질문

1. 조직검사 결과에서 분화도와 조직형은 무엇인가요?
2. 병기 검사는 무엇을, 언제 하나요?
3. 헬리코박터 검사 결과는 어떻고, 제균이 필요한가요?

4장. 병리·검사·병기

30초 요약: 먼저 볼 것은 **침윤 깊이(점막/점막하/근육층 이상) · 분화도 · 크기 · 궤양 · 림프관/혈관 침범 · 림프절**입니다.

검사	목적	기억할 점
위내시경·조직검사	진단, 위치·크기	선종도 절제 후 암으로 나올 수 있음
복부·골반 CT	림프절·간·복막 전이	기본
내시경 초음파	침윤 깊이	일부에서
PET/CT	원격전이	종류에 따라 잘 보이지 않을 수 있어 모두에게 하지는 않음
진단 복강경 + 복강 세척 세포검사	복막 전이 확인	진행위암 일부. 결과에 따라 치료 순서가 바뀜

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
1기	점막·점막하(림프절 1~2개 포함) 또는 근육층까지(림프절 없음)	내시경 절제 또는 수술. ※ "조기위암"과 "1기"는 같은 말이 아님
2~3기	근육층 이상, 림프절 전이	수술(D2 림프절 절제) + 항암

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 속
4기	원격전이(간·복막·먼 림프절 등)	바이오마커 기반 전신치료 ± 증상 완화 치료

- 위벽 안쪽으로 넓게 퍼지는 형태(미만형, 보우만 4형)는 내시경 조직검사서 암세포가 잘 나오지 않을 수 있습니다. 영상·내시경 소견이 강하게 의심되면 조직검사를 다시 하거나 여러 소견을 함께 보고 치료를 정하기도 합니다. '조직검사 음성'이 무슨 뜻인지 담당의에게 확인하세요.

■ **완전판에서 이어집니다** — 병리보고서 단어장, 수술 후 병리 읽기

5장. 바이오마커와 헬리코박터

30초 요약

- **MSI/MMR**은 국제 지침에서 병기와 관계없이 진단 시 모든 환자에게 검사를 권고합니다(국내 시행·급여 확인 필요).
- **HER2·PD-L1(CPS)·Claudin 18.2**는 주로 진행·전이성에서 치료 선택에 씁니다.
- **헬리코박터**는 위암의 중요한 원인 중 하나입니다. 감염이 확인되면 제균 치료를 상의하고, 가족 검사도 담당의와 이야기하세요. 감염은 흔하며 **당신 잘못이 아닙니다**.

검사	의미	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
MSI-H / dMMR	DNA 수선 이상	면역치료 반응 가능성, 림치증후군 선별
HER2	IHC 3+ 또는 2+·ISH 양성	항암 + HER2 표적(대표 예: 트라스투주맵), 이후 HER2 ADC

검사	의미	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
PD-L1 CPS	면역치료 효과 예측(점수에 따라 다름)	항암 + 면역치료
Claudin 18.2	위암 세포 표면 단백질	항암 + Claudin 18.2 표적(대표 예: 졸베특시맵)

- HER2 2+는 ISH로 확정합니다. 생검 조직이 작으면 부위에 따라 결과가 다를 수 있습니다.
- PD-L1은 **점수와 검사 종류(항체명)**를 함께 적어 두세요.

 **완전판에서 이어집니다** — 헬리코박터 제균 실무와 가족 검진

바이오마커 기록: MSI/MMR _ · **HER2** _ (ISH _) · **PD-L1 CPS** _ (검사 _) · **CLDN18.2** _ · 헬리코박터 ☐양성 ☐음성 → 제균 ☐예정 ☐완료 ☐재검 _____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 조기위암: 내시경 절제(ESD)

30초 요약: 크기·분화도·궤양·침윤 깊이가 기준 안이면(대표적인 예: 2cm 이하, 분화형, 궤양 없는 점막암 — 세부 기준은 한국 진료 지침과 병원 판단) **ESD로 위를 지키며 치료**할 수 있습니다. 절제 후 **최종 병리**로 근치 여부를 판정하고, 기준을 벗어나면 **추가 수술**을 권할 수 있습니다.

- ESD 후 확인할 3가지: ☐ 최종 병리의 근치 판정 ☐ 다음 내시경 날짜 ☐ 헬리코박터 제균
- **추가 수술을 권유받는 것은 실패가 아니라** 떼어 낸 조직에서 림프절 전이 위험이 확인되었다는 정보입니다.

 **완전판에서 이어집니다** — ESD 후 추가 수술 결정 가이드, ESD 전후 주의사항

- ESD 뒤 지연 출혈은 시술 후 2주 안에 생길 수 있습니다. **흑변·토혈·어지럼**이면 바로 연락하세요.

7장. 수술: 위절제와 D2 림프절 절제

30초 요약: 진행위암은 위의 일부 또는 전부와 주변 림프절을 함께 떼는 수술이 기본입니다. 이때 **D2 림프절 절제**가 한국·일본과 국제 지침(NCCN)이 권하는 표준 범위입니다. 조기위암은 범위를 줄인 수술(D1+, 기능보존 수술)을 하기도 합니다.

수술	내용
원위부(아전) 위절제	위의 아래쪽 2/3 정도
위 전절제	위 전체
유문보존· 근위부 위절제	조기위암에서 기능 보존 목적
복강경·로봇	병기·병원에 따라 선택
복강경·로봇	병기·병원에 따라 선택. 로봇수술은 국내에서 건강보험이 적용되지 않아 본인 부담이 클 수 있음(비용은 원무과 확인, 2026.10 기준 확인 필요)

■ **완전판에서 이어집니다** — 수술 후 회복 달력과 '수술 병원에 연락할 때 말할 문장'

8장. 수술 전후 항암: 한국과 국제 지침 나란히 보기

30초 요약: 2~3기 진행위암에서 **수술 후 보조항암**(한국·아시아 표준 축)과 **수술 전후(주변수술기) 항암**(서구 표준 축)은 모두 근거가 있는 전략입니다. 병원·병기·체력에 따라 정합니다.

비교	수술 먼저 + 보조항암	수술 전후 항암
주로 쓰는 곳	한국·일본 등	미국·유럽(NCCN)
순서	D2 수술 → 항암 6개월~1년	항암 몇 주기 → 수술 → 항암
대표 요법 예시	먹는 항암제 단독 또는 주사 +먹는 항암제 병용	여러 약을 묶은 병용요법(일부는 면역치료를 더하는 전략)

비교	수술 먼저 + 보조항암	수술 전후 항암
장점	정확한 병리 병기 후 결정	수술 전 종양을 줄이고 미세 전이 치료

- 수술 전후 항암에 **면역치료를 더하는 전략**이 새 범주로 추가되었습니다(국내 허가·급여 확인 필요).
- MSI-H 위암은 항암 반응이 다를 수 있어 치료 순서를 따로 상의합니다.
- 수술 후 보조항암은 회복 상태를 보며 **대개 수술 후 8주 안에** 시작합니다.
국내에서는 먹는 항암제를 1년 먹는 방식과, 먹는 항암제 + 주사를 3주 간격으로 6개월 하는 방식이 혼합니다(내 일정은 담당의 확인).

9장. 진행·전이성 위암

30초 요약: 1차 치료는 **항암을 바탕으로 바이오마커에 따라 HER2 표적·면역치료·Claudin 18.2 표적**을 더합니다. 출혈·통증·음식이 내려가지 않을 때는 **완화 방사선·내시경 스텐트·시술**을 함께 씁니다.

상황	범주(국내 허가·급여 확인 필요)
HER2 양성	항암 + HER2 표적(대표 예: 트라스투주맙, ± 면역치료) → 이후 HER2 ADC(대표 예: 트라스투주맙 데록스테칸) 등
HER2 음성, PD-L1 양성	항암 + 면역치료(대표 예: 니볼루맙·팜브롤리주맙)
Claudin 18.2 양성 (HER2 음성)	항암 + Claudin 18.2 표적(대표 예: 졸베톡시맙)
MSI-H	면역치료 중심
증상 완화	방사선(출혈·통증), 스텐트(통과 장애), 영양 지원

국내 급여 참고(2026년 6월 국내 공공 암정보 기준, 바뀔 수 있음):
면역치료는 약마다 정해진 PD-L1 기준을 넘을 때 급여가 되고, Claudin 18.2 표적치료제는 아직 비급여입니다. HER2 양성에서 HER2 ADC는 3차 치료부터 급여가 됩니다. 처방 전에 비용을 원무과에 확인하세요.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

위절제 후 먹는 법

30초 요약: 위 수술 뒤에는 "한 번에 많이"가 아니라 **"조금씩 자주, 천천히, 잘 씹어서"**가 원칙입니다. 체중이 계속 줄거나 식사량이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청하세요. 위 전절제 후에는 비타민 B12 보충이 오래 필요할 수 있습니다.

- **퇴원 후 첫 2주 하루 예시:** 아침 죽 반 공기 + 달걀찜 / 오전 간식 두유 반 컵 / 점심 진밥 반 공기 + 생선조림 / 오후 간식 바나나 반 개 / 저녁 진밥 반 공기 + 두부 / 밤 요거트 소량(유당 불편 시 조절).
- **초기 덤핑**(식후 30분 안 두근거림·식은땀·설사): 단 음료·국물을 식사와 함께 많이 먹지 않기, 식후 잠시 눕기.
- **후기 덤핑**(식후 1~3시간 저혈당): 단순당을 줄이고 단백질·복합탄수화물 함께.

■ **완전판에서 이어집니다** — 8주 식사 로드맵, 덤핑 일기, 장기 영양 관리(B12·철·칼슘)

추적

- 수술 후 정기 CT·내시경·혈액검사(간격은 병기에 따라). ESD 후에는 정해진 간격의 내시경이 핵심입니다.
- 흔한 예로 처음 3년은 3~6개월마다, 그 뒤 5년째까지는 6개월~1년마다 진료를 봅니다. 재발은 대부분 5년 안에 생기므로 **적어도 5년**은 추적을 이어 가세요 (간격은 병원마다 다름).
- 남은 위에 새 암이 생길 수 있어 내시경 추적이 중요합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ **완전판에서 이어집니다**

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 조기위암인가요, 진행위암인가요? 2. 분화도·조직형은 무엇인가요? 3. 내시경 절제가 가능한가요? 4. 수술이라면 범위(아전·전절제)와 방법은요? 5. 수술 후 항암인가요, 수술 전후 항암인가요? 6. MSI·HER2·PD-L1·Claudin 18.2 결과는요? 7. 헬리코박터 제균이 필요한가요? 가족도 검사하나요? 8. 수술 후 식사는 어떻게 하나요? 9. 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요? 10. 임상시험이나 다학제 진료가 가능한가요?

내 위암 한 장 요약

항목	내 기록
조직형·분화도	_____
병기	임상 _ → 병리 _
위치·크기	_____
림프절	_ / _
바이오마커	MSI _ HER2 _ PD-L1 _ CLDN18.2 _
헬리코박터	☐ 양성 ☐ 음성 · 제균 _____
첫 치료	ESD / 수술(종류 _____) / 항암 먼저
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 내시경 절제가 가능한가요? ② 수술과 항암의 순서는? ③ 헬리코박터와 가족 검진은?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 위암 용어사전
- 위암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Gastric Cancer, Version 4.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 위암 정보, 한국 위암 진료 가이드라인(대한위암학회 등), 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 쓰지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 쓰지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.

- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 병리보고서 단어장, 수술 후 병리 읽기
- 헬리코박터 제균 실무와 가족 검진
- ESD 후 추가 수술 결정 가이드, ESD 전후 주의사항
- 수술 후 회복 달력과 '수술 병원에 연락할 때 말할 문장'
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 8주 식사 로드맵, 덤핑 일기, 장기 영양 관리(B12·철·칼슘)
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)

- 위암 용어사전
 - 위암 자주 묻는 질문 12
 - 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
 - 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>